

EBOOK CỦA BÁC SĨ

50

BÀI TẬP

**giúp bạn khỏe mạnh
và sống trường thọ hơn**

Không dụng cụ • Tập tại nhà • 10 phút mỗi ngày

BÁC SĨ NGUYỄN XUÂN CHỨC

drchuc.com

Lời tựa: Cơ thể không hỏng vì tuổi, mà hỏng vì không dùng

Tôi là bác sĩ. Hơn hai mươi năm khám bệnh, tôi nhận ra một điều mà sách giáo khoa không dạy: hai người cùng tuổi, cùng bệnh nền, cùng loại thuốc, nhưng người vẫn đi chợ, lên cầu thang, bế cháu, còn người kia vịn tường từng bước. Khác nhau ở chỗ nào? Không phải ở gen. Khác ở chỗ một người vẫn **vận động mỗi ngày**, người kia đã ngừng từ lâu.

Sau tuổi 40, cơ thể chúng ta mất dần khối cơ. Y khoa gọi là thiếu cơ, sarcopenia. Mỗi năm mất khoảng nửa phần trăm đến một phần trăm, sau tuổi 60 còn nhanh hơn. Cơ yếu thì thăng bằng kém. Thăng bằng kém thì té ngã. Với người xương đã loãng, một cú té trong nhà tắm có thể là gãy cổ xương đùi và nhiều tháng nằm một chỗ. Tôi đã chứng kiến quá nhiều ca như vậy.

Nhưng tin vui là: **mất cơ là một trong rất ít quá trình lão hóa mà y học đã chứng minh có thể làm chậm, thậm chí đảo ngược**, chỉ bằng vận động đúng cách. Và không bao giờ là quá muộn. Nghiên cứu trên người 90 tuổi vẫn cho thấy cơ bắp tăng lên sau 8 tuần tập.

Cuốn sách này gom 50 bài tập tôi thường hướng dẫn cho bệnh nhân và người thân của mình. Tất cả đều có chung ba đặc điểm:

- **Không cần dụng cụ.** Chỉ cần một chiếc ghế, một bức tường, một cái khăn.
- **Không cần đến phòng tập.** Tập ngay trong phòng khách, cạnh giường, trong bếp.
- **An toàn cho người mới bắt đầu.** Mỗi bài đều có mức dễ hơn cho người yếu, và một lưu ý của bác sĩ về khi nào nên dừng.

Sách chia thành 7 phần theo mục tiêu: tim mạch, đường huyết, chân và gối, lưng và cổ, bàn tay bàn chân, thăng bằng, và sức mạnh. Cô chú anh chị **không cần tập cả 50 bài**. Hãy đọc mục "Cách dùng sách", chọn 5 đến 8

bài đúng với điều mình đang cần, tập 10 đến 15 phút mỗi ngày. Điều đặn quan trọng hơn nhiều so với tập nhiều.

Tôi viết cuốn này với một mong muốn giản dị: cô chú anh chị sống lâu, nhưng phải là **sống lâu mà còn tự đứng dậy được, tự đi được, tự chăm mình được**. Đó mới là trường thọ đúng nghĩa.

Bắt đầu từ hôm nay. Bắt đầu từ một bài.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Chúc

drchuc.com

Mục lục

Chương 1. Cách dùng sách: chọn đúng 5 bài cho mình

Chương 2. Tim mạch và tuần hoàn: cho máu chảy đều đến từng ngón tay

Chương 3. Đường huyết và chuyển hóa: cơ bắp là "kho chứa đường" lớn nhất cơ thể

Chương 4. Thân dưới, đầu gối và hông: sức mạnh để tự đứng dậy suốt đời

Chương 5. Lưng, cổ và tư thế: gỡ bỏ cái giá của một đời ngồi nhiều

Chương 6. Bàn tay, cổ tay và bàn chân: những "người thợ" bị lãng quên

Chương 7. Thăng bằng, dẻo dai và linh hoạt: không té ngã là không nằm một chỗ

Chương 8. Sức mạnh và chức năng: giữ cơ để giữ tự do

Chương 9. Dinh dưỡng và lối sống: bài tập chỉ là một nửa câu chuyện

CHƯƠNG 1

Cách dùng sách: chọn đúng 5 bài cho mình

Trước khi tập: 5 nguyên tắc an toàn của bác sĩ

1. **Không nín thở khi gắng sức.** Nín thở làm huyết áp tăng vọt. Luôn thở ra khi dùng sức, hít vào khi thả lỏng.
2. **Đau nhói là dừng, mỏi là bình thường.** Mỏi cơ, nóng cơ, run nhẹ là dấu hiệu cơ đang được rèn. Đau nhói ở khớp, đau lan xuống chân tay, chóng mặt, tức ngực là dừng ngay.
3. **Luôn có chỗ vịn.** Tập cạnh tường hoặc lưng ghế chắc trong 2 tuần đầu, nhất là các bài thăng bằng.
4. **Khởi động 2 phút, kết thúc 2 phút.** Đi bộ tại chỗ, xoay khớp trước khi tập. Hít thở chậm sau khi tập.
5. **Có bệnh nền, hỏi bác sĩ điều trị trước.** Đặc biệt nếu có bệnh tim mạch chưa ổn định, huyết áp cao chưa kiểm soát, mới mổ, hoặc loãng xương nặng đã từng gãy xương. Sách này không thay thế khám bệnh.

Bảng chọn bài theo điều mình đang gặp

Anh chị đang thấy gì	Ưu tiên phần	Gợi ý 5 bài đầu tiên
Lên 2 tầng cầu thang là thở dốc	Phần 1	Bài 1, 2, 5, 6, 7
Đường huyết cao, bụng to, hay buồn ngủ sau ăn	Phần 2	Bài 8, 9, 10, 11, 14
Đứng dậy khỏi ghế phải chống tay, gối kê	Phần 3	Bài 15, 18, 19, 21, 22
Đau lưng, mỏi cổ, vai gù vì ngồi nhiều	Phần 4	Bài 23, 24, 25, 26, 28
Tay yếu, mở nắp chai khó, chân tê	Phần 5	Bài 30, 31, 33, 34, 35
Đi hay chao, sợ té, cúi xuống khó	Phần 6	Bài 36, 37, 39, 41, 43
Muốn khỏe toàn thân, giữ cơ lâu dài	Phần 7	Bài 44, 45, 46, 48, 50

Cấu trúc mỗi bài tập

Mỗi bài trình bày theo cùng một khuôn để cô chú anh chị tra nhanh:

- **Tác dụng:** vì sao cần tập bài này.
- **Cách làm:** từng bước, ngắn gọn.
- **Liều lượng:** số lần, số hiệp, hoặc thời gian giữ.
- **Đễ hơn / Khó hơn:** điều chỉnh theo sức mình.
- **Góc bác sĩ:** lưu ý y khoa, ai nên tránh.

Lịch tập gợi ý 4 tuần (mỗi ngày 10 đến 15 phút)

Tuần	Làm gì	Mục tiêu
Tuần 1	Chọn 5 bài từ bảng trên. Mỗi bài làm mức "Dễ hơn".	Quen động tác, không đau.
Tuần 2	Giữ 5 bài, chuyển sang mức chuẩn. Thêm 1 bài thăng bằng (Phần 6).	Làm đủ số lần ghi trong sách.
Tuần 3	Thêm 2 bài từ Phần 7 (sức mạnh). Tổng 8 bài.	Cảm thấy đứng dậy, leo cầu thang nhẹ hơn.
Tuần 4	Giữ 8 bài, thử mức "Khó hơn" ở 2 đến 3 bài. Làm lại 3 bài kiểm tra ở cuối chương này.	So sánh với tuần 1.

Sau 4 tuần, đổi 2 đến 3 bài mới để cơ thể không quen nhàm. Tập 5 ngày, nghỉ 2 ngày mỗi tuần.

Ba bài kiểm tra tự làm tại nhà (làm ở tuần 1 và tuần 4)

Ghi kết quả vào bảng theo dõi ở cuối sách.

Kiểm tra 1. Đứng lên ngồi xuống 30 giây. Ngồi ghế, khoanh tay trước ngực, đứng lên ngồi xuống hết sức trong 30 giây. Người 60 đến 69 tuổi khỏe làm được 12 lần trở lên. Dưới 8 lần là cơ chân đã yếu đáng kể.

Kiểm tra 2. Đứng một chân. Đứng thẳng, nâng một chân, đếm giây. Dưới 10 giây ở tuổi 50 trở lên là dấu hiệu nguy cơ té ngã cao và cần tập Phần 6 ngay.

Kiểm tra 3. Ngồi xuống sàn rồi đứng lên. Ngồi bệt xuống sàn rồi đứng dậy, càng ít dùng tay hoặc gối chống càng tốt. Bài này ở Phần 7 sẽ hướng dẫn cách tập.

Việc cần làm ngay

Lấy bút, khoanh vào một dòng trong bảng chọn bài.
Đọc 5 bài đó. Tập ngay hôm nay, dù chỉ 5 phút.

BÀI 1 ĐẾN 7

Phần 1. Tim mạch và tuần hoàn

CHƯƠNG 2

Tim mạch và tuần hoàn: cho máu chảy đều đến từng ngón tay

Trái tim là một khối cơ. Cơ không dừng thì yếu. Bảy bài dưới đây làm tim đập nhanh vừa phải, đủ để máu được đẩy tới tận đầu ngón tay ngón chân, mà không gây quá sức. Dấu hiệu cường độ đúng: **thở hơi gấp nhưng vẫn nói được trọn câu**. Nếu không nói nổi, hãy chậm lại.

Bài 1. Đi bộ tại chỗ nâng cao gối



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/JCf-tMe8TDw

Tác dụng. Bài khởi động vận năng. Làm ấm tim, khớp gối, khớp háng mà không cần ra khỏi phòng.

Cách làm. 1. Đứng thẳng, hai tay thả lỏng, có thể đặt một tay lên lưng ghế. 2. Nhấc gối trái lên ngang hông, hạ xuống, rồi đổi gối phải. 3. Tay vung tự nhiên theo nhịp chân, mắt nhìn thẳng.

Liều lượng. 2 phút liên tục, nghỉ 30 giây, làm 2 lượt.

Dễ hơn. Nâng gối thấp hơn, vịn ghế. **Khó hơn.** Nâng gối cao hơn hông, tăng lên 4 phút.

Góc bác sĩ. Người thay khớp háng dưới 3 tháng chỉ nâng gối tới mức không đau. Đây là bài nên làm đầu tiên mỗi buổi tập, thay cho khởi động.

Bài 2. Bước sang ngang chạm mũi chân



Tác dụng. Tập cơ mặt ngoài đùi và hông, nhóm cơ giữ cho ta không ngã khi bước lệch.

Cách làm. 1. Đứng chụm chân giữa phòng. 2. Bước chân phải sang phải một bước rộng, kéo chân trái theo, chạm mũi chân trái xuống cạnh chân phải. 3. Bước ngược lại sang trái. Tay có thể vung ngang vai.

Liều lượng. 1 phút, nghỉ 20 giây, làm 3 lượt.

Dễ hơn. Bước ngắn, tay chống hông. **Khó hơn.** Bước rộng và nhún gối thấp khi chạm.

Góc bác sĩ. Sàn nhà phải khô, đi tất chống trượt hoặc chân trần. Sàn gạch bóng và tất trơn là nguyên nhân té hàng đầu trong nhà.

Bài 3. Đấm gió



Tác dụng. Tăng nhịp tim nhanh, đồng thời rèn vai, tay và phản xạ. Rất tốt để giải tỏa căng thẳng.

Cách làm. 1. Đứng chân trước chân sau, gối hơi chùng, hai nắm tay đưa lên ngang cằm. 2. Đấm thẳng tay trái ra trước, thu về, rồi đấm tay phải. Thở ra mỗi cú đấm. 3. Xoay nhẹ thân theo cú đấm để dùng cả cơ bụng.

Liều lượng. 30 giây đấm, 30 giây đi bộ tại chỗ, lặp 5 lần.

Dễ hơn. Đấm chậm, ngồi trên ghế. **Khó hơn.** Đấm nhanh hơn, thêm cú đấm móc.

Góc bác sĩ. Không duỗi khuỷu tay quá thẳng ở cuối cú đấm, dễ đau khớp khuỷu. Người đau vai cấp thì tập bài khác.

Bài 4. Nhún gót vùng tay



Tác dụng. Bài tim mạch nhẹ nhất trong sách, dành cho người mới, người thừa cân nhiều, hoặc người có gối yếu.

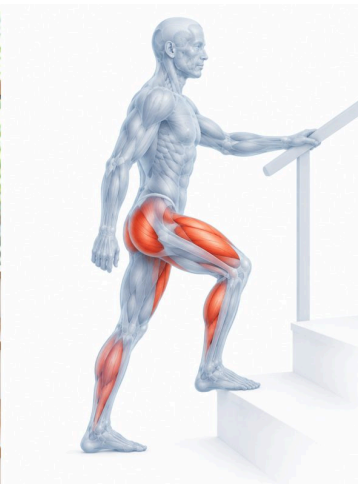
Cách làm. 1. Đứng thẳng, hai tay xuôi. 2. Đưa gót chân phải ra trước chạm sàn, mũi chân hướng lên, đồng thời vùng hai tay ra trước ngang vai. 3. Thu chân về, đổi chân trái. Nhịp đều như đang đi.

Liều lượng. 2 phút, nghỉ 30 giây, làm 3 lượt.

Dễ hơn. Không vung tay, vịn ghế. **Khó hơn.** Tay vung cao qua đầu, tăng nhịp.

Góc bác sĩ. Rất phù hợp cho người sau mổ tim đã được bác sĩ cho phép tập nhẹ. Theo dõi hơi thở, giữ ở mức nói được trọn câu.

Bài 5. Bước lên bậc thềm



Tác dụng. Mô phỏng leo cầu thang, rèn tim và cơ đùi cùng lúc. Đây là bài dự báo tốt nhất cho khả năng tự leo cầu thang ở tuổi 70, 80.

Cách làm. 1. Đứng trước bậc thềm hoặc bậc cầu thang cuối, tay vịn lan can. 2. Bước chân phải lên, kéo chân trái lên theo, rồi bước xuống chân phải trước, chân trái sau. 3. Đổi chân dẫn sau mỗi 10 lần.

Liều lượng. 1 phút, nghỉ 30 giây, làm 3 lượt.

Dễ hơn. Bậc thấp 10 cm, vịn cả hai tay. **Khó hơn.** Bậc cao 20 cm, không vịn, tăng lên 2 phút.

Góc bác sĩ. Người đau gối nên bước xuống chậm, vì lúc bước xuống gối chịu lực gấp 3 lần trọng lượng cơ thể. Nếu đau khi bước xuống, chỉ tập bước lên và đi vòng xuống.

Bài 6. Vẩy tay Dịch Cân Kinh



Tác dụng. Bài tập cổ truyền của phương Đông, giúp lưu thông khí huyết, ấm bàn tay bàn chân, dịu thần kinh. Nhiều bệnh nhân của tôi bảo tập xong người nhẹ như vừa tắm.

Cách làm. 1. Đứng hai chân rộng bằng vai, mười ngón chân bám nhẹ xuống sàn, hậu môn nhú nhẹ. 2. Hai tay đưa ra trước ngang rốn, lòng bàn tay úp, rồi vẩy mạnh ra sau, thả lỏng trở về trước. 3. Lực đưa ra sau, về trước là quán tính. Mắt nhìn thẳng, miệng khép, thở tự nhiên.

Liều lượng. Bắt đầu 200 cái, tăng dần 100 cái mỗi tuần, mục tiêu 1.000 cái trong khoảng 15 phút.

Dễ hơn. 100 cái, ngồi trên ghế. **Khó hơn.** 1.500 đến 2.000 cái, nhứu gối nhẹ khi vẩy.

Góc bác sĩ. Tập lúc bụng đói hoặc sau ăn 1 giờ. Người huyết áp thấp nếu thấy hoa mắt thì ngồi xuống ngay, uống một ngụm nước ấm. Đây là bài tôi thường khuyên người trên 70 tập thay cho chạy bộ.

Bài 7. Hai bài thở: hạ nhịp tim buổi tối và đánh thức cơ thể buổi sáng



Hơi thở là công cụ duy nhất vừa tự động vừa điều khiển được. Trong bài này tôi hướng dẫn hai kiểu thở làm hai việc ngược nhau, cô chú anh chị dùng đúng lúc thì rất quý, dùng nhầm lúc thì mất ngủ.

7A. Thở bụng 4-6 để hạ nhịp tim (ai cũng tập được)

Tác dụng. Kết thúc buổi tập, đưa nhịp tim về bình thường, hạ huyết áp, đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi và sửa chữa. Cũng là bài chữa mất ngủ và hồi hộp.

Cách làm. 1. Ngồi hoặc nằm, một tay đặt lên ngực, một tay lên bụng. 2. Hít vào bằng mũi đếm đến 4, tay trên bụng phồng lên, tay trên ngực gần như đứng yên. 3. Thở ra bằng miệng chúm môi, chậm, đếm đến 6.

Liều lượng. 10 nhịp thở sau mỗi buổi tập, hoặc 5 phút trước khi ngủ.

Dễ hơn. Hít 3 thở 4. **Khó hơn.** Hít 4, giữ 4, thở 8.

Góc bác sĩ. Thở ra dài hơn hít vào kích thích dây thần kinh phế vị, làm tim đập chậm lại. Người bệnh phổi tắc nghẽn nên tập bài này hàng ngày, đây chính là cách thở chúm môi mà bác sĩ hô hấp vẫn dạy.

7B. Thở Wim Hof để đánh thức cơ thể buổi sáng (bài nâng cao, có chống chỉ định)

► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài 7B: youtu.be/VsTmsHtogOc — thở cùng bác sĩ trọn 3 hiệp, 10 phút, có bộ đếm trên màn hình.

Tác dụng. Đây là kỹ thuật thở sâu theo chu kỳ kèm nín thở, mang tên Wim Hof, người Hà Lan. Khác hẳn bài 7A: nó **kích hoạt** chứ không làm dịu. Người tập thường thấy tỉnh táo, ấm người, đầu óc sáng ra, tâm trạng nhẹ hơn. Các nghiên cứu ban đầu ghi nhận kỹ thuật này làm tăng tạm thời hormone adrenaline và ảnh hưởng tới phản ứng viêm, nhưng đây vẫn là lĩnh vực đang nghiên cứu, chưa phải phương pháp điều trị bệnh.

Cách làm. Một buổi gồm 3 hiệp, tổng khoảng 10 phút.

1. **Nằm hoặc ngồi tựa lưng.** Tuyệt đối không đứng, không lái xe, không ở trong hoặc gần nước.
2. **30 nhịp thở sâu.** Hít vào thật sâu bằng mũi hoặc miệng, rồi buông ra tự nhiên, không cần đẩy hết hơi. Nhịp đều, khoảng 3 đến 4 giây một nhịp.
3. **Nín thở sau khi thở**

ra. Hết nhịp thứ 30, thở ra hết rồi giữ. Hiệp một giữ 30 giây, hiệp hai 60 giây, hiệp ba 90 giây. Thấy cần thở thì thở, không ép. 4. **Hồi phục.** Hít vào thật sâu, giữ 15 giây, rồi thở ra. Nghỉ vài nhịp, sang hiệp tiếp theo.

Liều lượng. 3 hiệp, mỗi sáng khi vừa thức dậy, trước khi ăn. Không tập buổi tối vì sẽ khó ngủ.

Để hơn. Chỉ làm 1 hiệp, nín thở 15 đến 20 giây. **Khó hơn.** Kéo dài thời gian nín thở, nhưng đừng bao giờ tranh đua với con số.

Góc bác sĩ. Đây là phần tôi muốn cô chú anh chị đọc kỹ nhất trong cả cuốn sách.

- **Tê tay, châm chích quanh miệng, hơi chóng mặt trong lúc thở là bình thường** và sẽ hết. Đó là do thải bớt khí carbonic.
- **Nguy cơ thật sự là ngất.** Vì vậy luôn nằm hoặc ngồi tựa. Đã có người chết đuối vì tập kỹ thuật này dưới nước. Không bao giờ tập khi bơi, tắm bồn, hay ngồi cạnh hồ.

- **Không tập** nếu đang mang thai, có động kinh, bệnh tim mạch chưa kiểm soát, từng đột quỵ, huyết áp cao chưa ổn định, phình mạch, hoặc từng ngất không rõ nguyên nhân.
- Người trên 70 tuổi, hoặc có bất kỳ bệnh nền nào, hãy hỏi bác sĩ điều trị của mình trước, và buổi đầu nên có người nhà ngồi cạnh.
- Tập xong ngồi yên một lúc, đừng đứng dậy vội.

Nếu cô chú anh chị thấy bài 7B quá sức hoặc thuộc nhóm chống chỉ định, **bỏ hẳn nó cũng không sao**. Bài 7A một mình đã đủ cho sức khỏe tim mạch và giấc ngủ.

BÀI 8 ĐẾN 14

Phần 2. Đường huyết và chuyển hóa

CHƯƠNG 3

Đường huyết và chuyển hóa: cơ bắp là "kho chứa đường" lớn nhất cơ thể

Ít người biết rằng **cơ bắp** là nơi tiêu thụ đường lớn **nhất** trong cơ thể, chiếm tới 70 đến 80 phần trăm lượng đường được lấy ra khỏi máu sau bữa ăn. Cơ càng nhiều và càng được dùng, đường huyết càng ổn, insulin càng nhạy. Bữa này không cần mớ hôi đầm đìa. Bí quyết nằm ở **thời điểm**: vận động ngay sau khi ăn.

Bài 8. Nhón gót khi ngồi (bài tập cơ bắp chân)



Tác dụng. Nghiên cứu năm 2022 của Đại học Houston cho thấy chỉ nhón gót liên tục khi ngồi, dùng cơ bắp chân sâu, có thể giảm đỉnh đường huyết sau ăn tới hơn 50 phần trăm. Cơ này đốt đường trực tiếp từ máu nhiều giờ liền mà không mỏi.

Cách làm. 1. Ngồi ghế, hai bàn chân đặt phẳng trên sàn, gối vuông góc. 2. Nhấc gót lên cao nhất có thể, mũi chân vẫn chạm sàn, rồi hạ gót xuống. 3. Nhịp đều, khoảng 1 giây một lần. Có thể vừa xem tivi vừa làm.

Liều lượng. 5 đến 10 phút liên tục, đặc biệt trong 1 giờ sau bữa ăn.

Dễ hơn. Tùng chân một. **Khó hơn.** Đặt hai tay đè nhẹ lên đùi để tăng kháng lực.

Góc bác sĩ. Đây là bài tôi khuyên mọi bệnh nhân tiểu đường hoặc tiền tiểu đường, kể cả người không đi lại được. Cũng là bài chống huyết khối tĩnh mạch cho người ngồi lâu, đi máy bay đường dài.

Bài 9. Đi bộ 10 phút sau ăn



Tác dụng. Tổng hợp nhiều nghiên cứu cho thấy đi bộ nhẹ trong vòng 60 đến 90 phút sau ăn làm giảm đường huyết sau ăn rõ rệt hơn đi bộ cùng thời lượng vào lúc khác.

Cách làm. 1. Sau bữa ăn 10 đến 15 phút, đứng dậy đi bộ chậm quanh nhà, ngoài sân, hoặc đi bộ tại chỗ. 2. Tốc độ thông thả, vẫn trò chuyện được. 3. Không cần đi xa, chỉ cần không ngồi hoặc nằm ngay sau ăn.

Liều lượng. 10 phút sau mỗi bữa chính, ngày 3 lần.

Dễ hơn. 5 phút, hoặc thay bằng Bài 8. **Khó hơn.** 15 phút, đi nhanh hơn.

Góc bác sĩ. Người hay tụt huyết áp sau ăn nên đi chậm và ở trong nhà. Không đi bộ ngay lập tức khi vừa ăn no căng, chờ 10 phút.

Bài 10. Ngồi tựa tường



Tác dụng. Tập đẳng trường, tức là giữ yên mà cơ vẫn gồng. Bài này được nhiều nghiên cứu ghi nhận là **hạ huyết áp hiệu quả**, đồng thời đùi gồng liên tục sẽ hút đường từ máu.

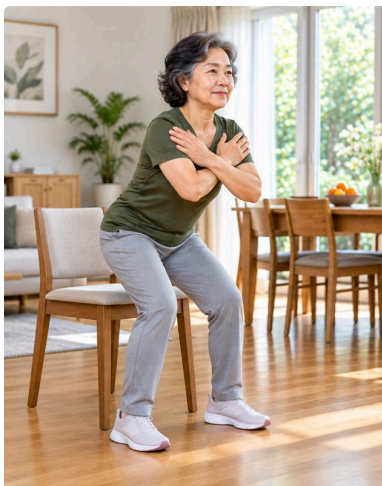
Cách làm. 1. Đứng lưng tựa tường, hai chân cách tường khoảng 40 đến 50 cm, rộng bằng vai. 2. Trượt lưng xuống cho tới khi đùi nghiêng khoảng 45 độ với sàn, gối không vượt quá mũi chân. 3. Giữ yên, thở đều, không nín thở.

Liều lượng. Giữ 20 đến 45 giây, nghỉ 1 phút, làm 3 lượt.

Dễ hơn. Trượt thấp ít hơn, giữ 10 giây. **Khó hơn.** Đùi song song sàn, giữ 1 phút.

Góc bác sĩ. Người đau khớp gối chỉ trượt xuống tới mức không đau. Người huyết áp cao tuyệt đối thở đều, vì nín thở khi gồng làm huyết áp vọt lên nguy hiểm.

Bài 11. Đứng lên ngồi xuống 1 phút



Tác dụng. Dùng nhóm cơ lớn nhất cơ thể là đùi và mông để tiêu thụ đường nhanh. Cũng là bài đo sức khỏe chân đã nói ở chương đầu.

Cách làm. 1. Ngồi ghế chắc, hai chân rộng bằng vai, bàn chân hơi lùi về sau gót. 2. Nghiêng người ra trước, đứng thẳng dậy, thở ra khi đứng. 3. Ngồi xuống chậm trong 3 giây, không thả người rơi xuống ghế.

Liều lượng. 1 phút liên tục, làm 2 đến 3 lượt trong ngày, tốt nhất sau bữa ăn.

Dễ hơn. Chống tay lên đùi hoặc tay vịn. **Khó hơn.**
Khoanh tay trước ngực, hoặc ôm chai nước 1,5 lít.

Góc bác sĩ. Ghế phải không có bánh xe. Người mới mổ
gối, mổ háng tập theo hướng dẫn của bác sĩ phục hồi
chức năng.

Bài 12. Nhón gót đứng



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/jLIYEEArWVo

Tác dụng. Tập cơ bắp chân mạnh hơn Bài 8, đồng thời rèn thẳng bằng. Bắp chân được gọi là "trái tim thứ hai" vì nó bơm máu tĩnh mạch từ chân về tim.

Cách làm. 1. Đứng sau lưng ghế, hai tay đặt nhẹ lên ghế, chân rộng bằng hông. 2. Nhón gót lên cao nhất, giữ 1 giây ở đỉnh. 3. Hạ gót xuống chậm trong 3 giây.

Liều lượng. 15 lần, nghỉ 30 giây, làm 3 hiệp.

Dễ hơn. Vịn chắc hai tay, nhón thấp. **Khó hơn.** Chỉ chạm một ngón tay lên ghế, hoặc nhón từng chân.

Góc bác sĩ. Người bị giãn tĩnh mạch chân và phù chân chiều tối nên tập bài này mỗi ngày. Nếu chuột rút, dừng lại, duỗi thẳng chân, kéo mũi chân về phía mình.

Bài 13. Đi lùi



Tác dụng. Đi lùi dùng nhiều cơ đùi trước hơn đi tiến, tốn năng lượng nhiều hơn 30 phần trăm cùng quãng đường, và giảm áp lực lên khớp gối. Còn rèn não bộ vì đây là kiểu vận động lạ.

Cách làm. 1. Chọn hành lang hoặc phòng trống, không có vật cản, tốt nhất dọc theo tường. 2. Đi lùi chậm, mũi chân chạm sàn trước rồi tới gót, tay chạm nhẹ tường. 3. Đi 10 bước lùi, rồi 10 bước tiến, lặp lại.

Liều lượng. 3 đến 5 phút mỗi ngày.

Dễ hơn. Vịn tường liên tục, bước ngắn. **Khó hơn.**
Không vịn, đi lùi lên dốc nhẹ ngoài sân.

Góc bác sĩ. Người có tiền sử chóng mặt, rối loạn tiền
đỉnh cần có người đi cùng. Bài này tôi hay dùng cho
người đau gối mạn tính vì đi lùi ít ép sụn gối hơn đi tới.

Bài 14. Ngắt quãng ngồi: đứng dậy mỗi 30 phút



Tác dụng. Ngồi liên tục hơn 30 phút làm cơ ngừng "hút" đường, dù buổi sáng đã tập thể dục. Chỉ cần đứng dậy 2 đến 3 phút là chuyển hóa được bật lại. Đây không hẳn là bài tập, mà là thói quen quan trọng nhất trong phần này.

Cách làm. 1. Đặt hẹn giờ 30 phút trên điện thoại hoặc đồng hồ. 2. Chuông reo thì đứng dậy: rót nước, đi 20 bước, làm 10 lần Bài 11, hoặc 20 lần Bài 12. 3. Ngồi xuống, đặt lại hẹn giờ.

Liều lượng. Suốt thời gian thức, mỗi 30 phút ngồi thì đứng 2 đến 3 phút.

Dễ hơn. Mỗi 45 phút một lần. **Khó hơn.** Mỗi 20 phút, và mỗi lần đứng dậy làm một bài trong Phần 3.

Góc bác sĩ. Nghiên cứu cho thấy người ngồi trên 8 giờ mỗi ngày có nguy cơ tử vong sớm cao hơn người ngồi ít, kể cả khi họ có tập thể dục. Cái ghế nguy hiểm hơn ta nghĩ. Xem tivi cũng vậy: hết một tập phim thì đứng dậy.

BÀI 15 ĐẾN 22

Phần 3. Thân dưới, đầu gối và hông

CHƯƠNG 4

Thân dưới, đầu gối và hông: sức mạnh để tự đứng dậy suốt đời

Đôi chân là "cột trụ" của tuổi già. Khi cơ đùi yếu, ta chống tay đứng dậy, rồi vịn cầu thang, rồi ngại ra khỏi nhà, rồi ngồi nhiều hơn, và cơ lại càng yếu. Vòng xoáy này bắt đầu rất âm thầm từ tuổi 50. Tám bài dưới đây chặn nó lại. Nhiều người sợ tập chân vì đau gối, nhưng sự thật là **cơ đùi khỏe chính là tấm đệm bảo vệ khớp gối** tốt nhất.

Bài 15. Đứng lên ngồi xuống từ ghế (bài tập quan trọng nhất sách)



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/wuQ1jwGFhpE

Tác dụng. Nếu chỉ tập một bài trong cả cuốn sách, hãy tập bài này. Nó rèn đúng động tác ta làm hàng chục lần mỗi ngày: rời giường, rời ghế, rời bồn cầu. Người còn tự đứng dậy được là người còn tự chăm mình được.

Cách làm. 1. Ngồi mép ghế, chân rộng bằng vai, gót chân lùi về sau gối một chút. 2. Nghiêng thân ra trước,

"mũi qua mũi chân", rồi đẩy sàn đứng thẳng dậy. Thở ra khi đứng. 3. Đẩy hông ra sau, ngồi xuống chậm trong 3 giây, chạm ghế nhẹ rồi lại đứng lên.

Liều lượng. 10 lần, nghỉ 1 phút, làm 3 hiệp. Mỗi ngày.

Dễ hơn. Ghế cao hơn, kê gối lên mặt ghế, chống tay lên đùi. **Khó hơn.** Ghế thấp hơn, khoanh tay, hoặc đứng lên bằng một chân với chân kia duỗi ra trước.

Góc bác sĩ. Đầu gối luôn hướng theo mũi chân, không khép vào trong. Người thay khớp gối làm được bài này sau 6 tuần theo hướng dẫn bác sĩ.

Bài 16. Tấn mã



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/EifR_h-3CLk

Tác dụng. Bí quyết từ võ thuật phương Đông. Đứng yên một chỗ mà đùi run, mồ hôi túa ra. Tấn mã rèn cơ đùi, mông, cơ lõi, và dạy cơ thể "cắm rễ" xuống đất, tức là thăng bằng.

Cách làm. 1. Hai chân rộng gấp rưỡi vai, mũi chân hơi xoay ra ngoài. 2. Hạ hông xuống như ngồi lên một chiếc ghế vô hình, lưng thẳng, đầu gối hướng theo mũi

chân. 3. Hai tay nắm hờ đặt ngang hông hoặc đưa ra trước, mắt nhìn thẳng, thở đều.

Liều lượng. Giữ 20 đến 30 giây, nghỉ 1 phút, làm 3 lượt. Tăng 10 giây mỗi tuần, mục tiêu 2 phút.

Dễ hơn. Hạ thấp ít hơn, lưng tựa tường. **Khó hơn.** Đùi song song sàn, giữ 2 đến 3 phút.

Góc bác sĩ. Gối không được vượt quá mũi chân, nếu vượt là đang dồn lực sai lên gối. Người đau gối nặng chỉ hạ đến góc không đau. Đây là bài tôi thấy rõ nhất sự thay đổi trên bệnh nhân sau 1 tháng.

Bài 17. Bước chùng chân vịn ghế



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/0BJOfk_p40rY

Tác dụng. Tập từng chân riêng, phát hiện chân nào yếu hơn. Rèn cơ đùi, mông, và thăng bằng động.

Cách làm. 1. Đứng cạnh lưng ghế, một tay vịn. 2. Bước chân ngoài lên trước một bước dài, hạ thân thẳng xuống cho tới khi gối sau gần chạm sàn, gối trước ở ngay trên cổ chân. 3. Đẩy gót chân trước đứng dậy, thu chân về. Đổi bên.

Liều lượng. 8 lần mỗi chân, làm 2 hiệp.

Dễ hơn. Hạ thấp một nửa, vịn cả hai tay. **Khó hơn.** Không vịn, hoặc bước lùi thay vì bước tới.

Góc bác sĩ. Bước quá ngắn là lỗi hay gặp, làm gối trước vượt mũi chân và đau. Nếu đau ở bánh chè, chuyển sang bước lùi, gối sẽ dễ chịu hơn.

Bài 18. Duỗi gối khi ngồi



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/uiWtxK6doLc

Tác dụng. Rèn riêng cơ tứ đầu đùi, nhóm cơ giữ cho bánh chè trượt đúng rãnh. Đây là bài số một cho người đau gối, thoái hóa khớp gối, trước và sau mổ gối.

Cách làm. 1. Ngồi ghế, lưng thẳng, hai tay nắm mép ghế. 2. Duỗi thẳng chân phải ra trước, mũi chân kéo về phía mình, siết cứng đùi, giữ 3 giây. 3. Hạ xuống chậm. Đổi chân.

Liều lượng. 12 lần mỗi chân, làm 3 hiệp.

Dễ hơn. Không giữ ở đỉnh, duỗi chưa thẳng hết. **Khó hơn.** Giữ 10 giây, hoặc đeo túi cát nhỏ ở cổ chân.

Góc bác sĩ. Bài này không làm hại sụn gối vì không có lực đè lên khớp. Người đang tràn dịch khớp gối vẫn tập được ở tầm không đau. Tập đều là cách chống mô gối rẻ nhất.

Bài 19. Cầu mông



Tác dụng. Cơ mông là cơ lớn nhất cơ thể nhưng bị "ngủ quên" ở người ngồi nhiều. Mông yếu thì lưng dưới và gối phải gánh thay, sinh đau lưng, đau gối.

Cách làm. 1. Nằm ngửa trên thảm hoặc giường cứng, gối gập, bàn chân đặt phẳng cách mông một gang tay. 2. Siết mông, nâng hông lên cho tới khi vai, hông, gối thành một đường thẳng. Thở ra khi nâng. 3. Giữ 2 giây, hạ chậm.

Liều lượng. 12 lần, làm 3 hiệp.

Dễ hơn. Nâng thấp hơn. **Khó hơn.** Giữ 10 giây ở đỉnh, hoặc nâng bằng một chân với chân kia duỗi thẳng.

Góc bác sĩ. Không uốn lưng quá mức ở đỉnh, lực phải ở mông chứ không ở thắt lưng. Người thoát vị đĩa đệm tập được và nên tập bài này.

Bài 20. Nâng chân sang ngang



Tác dụng. Rèn cơ mông nhỡ ở mặt ngoài hông. Cơ này giữ cho khung chậu không nghiêng khi đứng một chân, tức là mỗi bước đi. Yếu cơ này là nguyên nhân hay gặp của dáng đi lắc lư và té ngã.

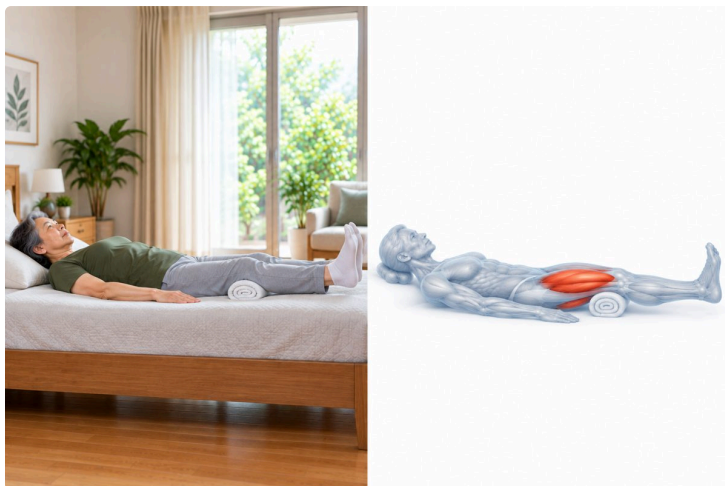
Cách làm. 1. Đứng sau lưng ghế, hai tay vịn. 2. Nâng thẳng chân phải sang ngang khoảng 30 đến 45 độ, mũi chân hướng thẳng ra trước, thân không nghiêng. 3. Giữ 1 giây, hạ chậm. Đổi chân.

Liều lượng. 12 lần mỗi chân, làm 2 đến 3 hiệp.

Dễ hơn. Nâng thấp hơn. **Khó hơn.** Giữ 5 giây ở đỉnh, hoặc chỉ chạm một ngón tay vào ghế.

Góc bác sĩ. Lỗi thường gặp là nghiêng thân sang bên đối diện để nâng chân cao hơn. Thà nâng thấp mà thân thẳng. Người thay khớp háng nên tập bài này lâu dài.

Bài 21. Siết đùi ép khăn



Tác dụng. Bài nhẹ nhất nhưng đánh thức cơ đùi trong, cho người đau gối cấp, người sau mổ, người nằm lâu. Có thể tập ngay trên giường.

Cách làm. 1. Nằm ngửa hoặc ngồi duỗi chân, cuộn một chiếc khăn kê dưới khoeo chân phải. 2. Ép khoeo xuống khăn, siết cứng cơ đùi, kéo mũi chân về phía mình, giữ 5 giây. 3. Thả lỏng 5 giây. Đổi chân.

Liều lượng. 10 lần mỗi chân, làm 3 lượt, có thể làm nhiều lần trong ngày.

Dễ hơn. Giữ 3 giây. **Khó hơn.** Giữ 10 giây, kết hợp nâng gót chân khỏi giường 5 cm.

Góc bác sĩ. Đây là bài phục hồi chức năng chuẩn sau mổ dây chằng, mổ thay gối. Người lớn tuổi ốm nằm 1 tuần có thể mất đến 10 phần trăm cơ đùi. Tập bài này ngay trên giường bệnh để giữ cơ.

Bài 22. Nhón gót một chân



Tác dụng. Bài nâng cấp của Bài 12, rèn sức mạnh bắp chân từng bên và thăng bằng. Bắp chân khỏe là điều kiện để đẩy người bước lên bậc thềm.

Cách làm. 1. Đứng sau ghế, hai tay vịn nhẹ, gập gối trái nhắc chân trái khỏi sàn. 2. Nhón gót chân phải lên cao nhất, giữ 1 giây. 3. Hạ xuống chậm 3 giây. Đổi chân.

Liều lượng. 10 lần mỗi chân, làm 3 hiệp.

Dễ hơn. Chân kia chạm nhẹ mũi xuống sàn dễ đỡ. **Khó hơn.** Bỏ tay vịn, hoặc đứng trên mép bậc thêm để gót hạ sâu hơn.

Góc bác sĩ. Người 60 tuổi khỏe mạnh nhón được 15 đến 20 lần mỗi chân. Dưới 8 lần là bắp chân đã yếu, nên tập bài này 5 ngày mỗi tuần.

BÀI 23 ĐẾN 29

Phần 4. Lưng, cổ và tư thế

CHƯƠNG 5

Lưng, cổ và tư thế: gỡ bỏ cái giá của một đời ngồi nhiều

Cột sống có 33 đốt và hàng trăm cơ nhỏ quanh nó. Ngồi nhiều, cúi điện thoại nhiều làm cơ phía trước co ngắn, cơ phía sau bị kéo dài và yếu đi. Kết quả là vai gù, cổ rùa, đau thắt lưng. Bảy bài này làm ngược lại quá trình đó: **mở phía trước, khỏe phía sau**. Chỉ 5 phút mỗi sáng là đủ để thấy khác.

Bài 23. Mèo và bò



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/AVEy5_3Cg94

Tác dụng. Bài "bôi trơn" cột sống. Mỗi đốt sống được gập rồi uốn nhẹ, dịch khớp được đẩy vào đĩa đệm. Là bài nên làm đầu tiên mỗi sáng khi lưng còn cứng.

Cách làm. 1. Quỳ bốn điểm trên thảm: tay dưới vai, gối dưới hông. 2. Thở ra, cong lưng lên trần như con mèo, cằm hướng vào ngực. 3. Hít vào, võng lưng

xuống, ngực đưa ra trước, mắt nhìn lên. Chuyển động chậm, đều.

Liều lượng. 10 nhịp, làm 2 lượt.

Dễ hơn. Ngồi trên ghế, tay đặt lên đùi, làm cùng động tác. **Khó hơn.** Giữ mỗi tư thế 5 giây.

Góc bác sĩ. Người đau cổ tay đặt tay trên nắm đấm hoặc kê khăn. Người thoát vị đĩa đệm đang đau cấp giảm biên độ động tác vồng lưng.

Bài 24. Chim và chó



Tác dụng. Được các chuyên gia cột sống xếp vào ba bài lỗi an toàn nhất cho người đau lưng. Rèn cơ dựng sống, cơ mông, và dạy cơ thể giữ thắt lưng ổn định khi tay chân cử động.

Cách làm. 1. Quỳ bốn điểm như Bài 23, lưng phẳng như mặt bàn. 2. Duỗi thẳng tay phải ra trước và chân trái ra sau cùng lúc, ngang thân, không cao hơn. 3. Giữ 3 giây, thân không xoay, không võng. Thu về. Đổi bên.

Liều lượng. 8 lần mỗi bên, làm 2 hiệp.

Dễ hơn. Chỉ duỗi tay, hoặc chỉ duỗi chân. **Khó hơn.** Giữ 10 giây, hoặc đưa khuỷu tay chạm gối dưới bụng rồi duỗi ra.

Góc bác sĩ. Tưởng tượng có cốc nước đặt trên thắt lưng, không được đổ. Bài này là "thuốc" hàng ngày cho người đau thắt lưng mạn tính.

Bài 25. Kéo cằm



Tác dụng. Cổ rùa là khi đầu nhô ra trước vai. Mỗi 2,5 cm nhô ra, cổ phải gánh thêm khoảng 4 đến 5 kg. Bài kéo cằm đưa đầu về đúng chỗ, giảm mỏi cổ, đau đầu do căng cơ.

Cách làm. 1. Ngồi hoặc đứng thẳng, mắt nhìn ngang. 2. Kéo cằm thẳng ra sau như đang tạo "cằm đôi", không cúi, không ngửa. Cảm giác gáy dài ra. 3. Giữ 5 giây, thả lỏng.

Liều lượng. 10 lần, làm 3 lượt rải trong ngày, nhất là sau khi dùng điện thoại lâu.

Dễ hơn. Nằm ngửa không gối, ấn gáy xuống giường.

Khó hơn. Đặt hai ngón tay lên cằm đẩy nhẹ để tăng kháng lực.

Góc bác sĩ. Người thoái hóa đốt sống cổ, tê tay do chèn ép rễ thần kinh cổ nên tập bài này mỗi giờ khi làm việc máy tính. Nếu tê tăng khi tập, dừng và đi khám.

Bài 26. Thiên thần trên tường



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/DQUW-AzSpqPU

Tác dụng. Mở lồng ngực, kéo vai ra sau, rèn cơ giữa hai bả vai. Đây là "thuốc giải" cho vai gù do ngồi máy tính, lái xe, xem điện thoại.

Cách làm. 1. Đứng lưng tựa tường, gót cách tường 10 cm, thắt lưng, lưng trên, gáy chạm tường. 2. Giơ hai tay hình chữ W, khuỷu và mu bàn tay chạm tường. 3. Trượt

tay lên trên thành chữ Y, cố giữ tay không rời tường, rồi trượt về.

Liều lượng. 10 lần chậm, làm 2 lượt.

Dễ hơn. Không cần tay chạm tường hoàn toàn, chỉ cố gắng hướng về tường. **Khó hơn.** Giữ ở chữ Y 5 giây.

Góc bác sĩ. Lần đầu làm, nhiều người không đưa được tay chạm tường. Đó là thước đo cho thấy ngực đã co cứng nhiều năm. Sau 3 tuần tập, tay sẽ chạm được. Người đau vai cấp tính hoặc rách gân vai thì hoãn.

Bài 27. Mở sách nằm nghiêng



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/ZjZ31ZnQ89Y

Tác dụng. Xoay cột sống ngực, phần hay bị "khóa" nhất. Ngực cứng thì thắt lưng và cổ phải xoay thay, sinh đau. Bài này còn giúp thở sâu hơn.

Cách làm. 1. Nằm nghiêng bên phải, hai gối gập 90 độ chồng lên nhau, hai tay duỗi thẳng ra trước chồng lên nhau. 2. Hít vào, mở tay trái vẽ một vòng cung lên trần rồi sang trái, mắt và đầu theo tay, gối vẫn ép sần. 3.

Thở ra, giữ 3 giây ở điểm mở nhất, rồi khép về. Đổi bên.

Liều lượng. 8 lần mỗi bên.

Dễ hơn. Kê gối giữa hai gối, mở tay tới đầu hay tới đó.

Khó hơn. Giữ ở điểm mở 10 giây.

Góc bác sĩ. Người sau mở tim mở lồng ngực cần chờ đủ 3 tháng và hỏi bác sĩ. Người thoái hóa cột sống làm chậm, không ép mạnh.

Bài 28. Tắm ván trên gối



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/MWQVimAl-Rg

Tác dụng. Tắm ván, hay plank, là viên gạch nền của sức khỏe vận động. Nó rèn cơ lõi gồm bụng, lưng dưới và hông, giống như cái trụ giữa của căn nhà. Trụ vững thì đi đứng vững, cúi không đau lưng. Bản tắm ván trên gối phù hợp hầu hết người trên 40.

Cách làm. 1. Nằm sấp, chống hai khuỷu tay ngay dưới vai, hai gối chạm sàn. 2. Nâng hông lên để vai, hông,

gối thành một đường thẳng. Kéo rốn hút vào cột sống.

3. Thở đều, giữ. Không võng lưng, không nhong mông.

Liều lượng. Giữ 20 đến 30 giây, nghỉ 30 giây, làm 3 lượt. Tăng 5 giây mỗi tuần.

Dễ hơn. Chống tay lên mặt bàn hoặc lưng ghế, thân nghiêng. **Khó hơn.** Chống mũi chân thay vì gối, tấm ván đầy đủ; hoặc tấm ván nghiêng chống một khuỷu tay.

Góc bác sĩ. Tuyệt đối không nín thở. Người đau vai cấp chờ hết đợt đau. Tấm ván tốt hơn gấp bụng rất nhiều cho người đau lưng vì cột sống không phải gấp đi gấp lại.

Bài 29. Nâng ngực nằm sấp



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/AVEy5_3Cg94

Tác dụng. Rèn trực tiếp nhóm cơ dựng sống dọc hai bên cột sống, nhóm cơ yếu đi nhiều nhất ở người ngồi lâu. Lưng khỏe thì đứng thẳng được lâu mà không mỏi.

Cách làm. 1. Nằm sấp trên thảm, trán tựa xuống, hai tay xuôi dọc thân, lòng bàn tay úp. 2. Siết mông, nâng ngực và đầu lên khỏi sàn khoảng 5 đến 10 cm, mắt nhìn xuống sàn, gáy thẳng. 3. Giữ 3 giây, hạ chậm.

Liều lượng. 10 lần, làm 2 hiệp.

Dễ hơn. Chỉ nâng 2 cm, hoặc đặt hai tay dưới trán.

Khó hơn. Hai tay duỗi thẳng ra trước, nâng cả tay và chân, tư thế siêu nhân.

Góc bác sĩ. Không ngửa cổ nhìn lên trước, sẽ đau gáy. Người hẹp ống sống thắt lưng hoặc trượt đốt sống nên hỏi bác sĩ trước, vì động tác uốn lưng có thể làm tăng triệu chứng.

BÀI 30 ĐẾN 35

Phần 5. Bàn tay, cổ tay và bàn chân

CHƯƠNG 6

Bàn tay, cổ tay và bàn chân: những "người thợ" bị lãng quên

Bàn tay có 27 xương, bàn chân có 26 xương, cộng lại là hơn một phần tư số xương của cả cơ thể. Chúng làm việc suốt ngày mà hầu như không ai tập cho chúng. Lực bóp bàn tay được y học dùng như một **thước đo tuổi thọ**: người có lực bóp yếu có nguy cơ tử vong sớm và mất tự chủ cao hơn rõ rệt. Còn bàn chân là bộ cảm biến thăng bằng, chân tê là mất cảm giác sàn, là dễ té. Sáu bài này chỉ mất 5 phút và có thể làm khi xem tivi.

Bài 30. Bóp khăn



Tác dụng. Tăng lực bóp bàn tay, chỉ số được nhiều nghiên cứu lớn coi là dự báo tuổi thọ tốt hơn cả huyết áp. Lực bóp khỏe nghĩa là mở nắp chai được, xách được túi đi chợ, vịn được lan can khi trượt chân.

Cách làm. 1. Cuộn một chiếc khăn mặt lại, hoặc dùng quả bóng tennis, nắm trong lòng bàn tay. 2. Bóp chặt hết sức, giữ 5 giây, cảm nhận cả cẳng tay gồng lên. 3. Thả lỏng hoàn toàn 5 giây. Đổi tay.

Liều lượng. 10 lần mỗi tay, làm 3 lượt rải trong ngày.

Dễ hơn. Bóp 50 phần trăm sức, giữ 3 giây. **Khó hơn.**
Dùng khăn ướt vắt kiệt nước, hoặc treo người ở Bài 49.

Góc bác sĩ. Người viêm khớp dạng thấp tập trong giai đoạn không sưng đau, bóp nhẹ. Người mới bị hội chứng ống cổ tay nên bóp ngắn 3 giây, nếu tê tăng thì dừng.

Bài 31. Ngón cái chạm từng ngón



Tác dụng. Rèn sự khéo léo, phối hợp thần kinh và cơ nhỏ bàn tay. Giữ khả năng cài cúc áo, cầm đũa, viết chữ ở tuổi cao. Còn là bài kích thích não bộ vì bàn tay chiếm vùng điều khiển rất lớn trên vỏ não.

Cách làm. 1. Xòe bàn tay phải, lòng bàn tay hướng lên. 2. Chạm đầu ngón cái lần lượt vào đầu ngón trỏ, giữa, áp út, út, rồi chạy ngược lại. 3. Làm chậm và chính xác trước, sau đó tăng tốc. Làm cả hai tay cùng lúc.

Liều lượng. 10 vòng mỗi tay, làm 2 lượt. Thêm 1 lượt với mắt nhắm.

Dễ hơn. Từng tay một, mắt nhìn. **Khó hơn.** Hai tay cùng lúc nhưng ngược chiều nhau, hoặc vừa làm vừa đếm ngược từ 100 theo bước 7.

Góc bác sĩ. Người sau tai biến nhẹ, người bắt đầu run tay nên tập bài này hàng ngày. Nếu một tay chậm và vụng hơn tay kia rõ rệt mà trước đây không thế, đi khám thần kinh.

Bài 32. Gập duỗi và xoay cổ tay



Tác dụng. Cổ tay cứng làm mọi việc nhà thành khó chịu: vặn vòi nước, cầm chảo, chống tay khi ngã. Bài này giữ tầm vận động và làm dịu đau do dùng điện thoại nhiều.

Cách làm. 1. Duỗi thẳng tay phải ra trước, lòng bàn tay úp. Dùng tay trái kéo nhẹ các ngón tay phải xuống dưới, giữ 15 giây. 2. Lật lòng bàn tay ngửa, kéo các ngón tay xuống dưới, giữ 15 giây. 3. Nắm hờ hai tay, xoay cổ tay 10 vòng theo chiều kim đồng hồ, 10 vòng ngược lại.

Liều lượng. Toàn bộ chuỗi làm 2 lượt, sáng và tối.

Dễ hơn. Không kéo, chỉ tự gập duỗi. **Khó hơn.** Chống hai lòng bàn tay xuống bàn, ngón tay hướng về phía mình, nghiêng người ra sau để kéo giãn.

Góc bác sĩ. Tê ngón cái, trỏ, giữa về đêm phải vẫy tay mới đỡ là dấu hiệu hội chứng ống cổ tay. Bài này giúp giai đoạn nhẹ, nếu tê kéo dài hơn 2 tuần thì đi khám.

Bài 33. Nhặt khăn bằng ngón chân



Tác dụng. Đánh thức các cơ nhỏ trong lòng bàn chân, nhóm cơ đỡ vòm bàn chân. Vòm chân sụp gây đau gót, đau gôi, đau lưng. Cơ chân khỏe cũng bám sàn tốt hơn khi đi.

Cách làm. 1. Ngồi ghế, trải một chiếc khăn mỏng dưới bàn chân trần. 2. Dùng các ngón chân co lại kéo khăn về phía gót, từng chút một, cho tới khi hết khăn. 3. Đẩy khăn ra lại bằng cách xòe và duỗi ngón chân. Đổi chân.

Liều lượng. 3 lần kéo hết khăn mỗi chân.

Dễ hơn. Chỉ co duỗi ngón chân không có khăn. **Khó hơn.** Đặt một cuốn sách mỏng lên đầu khăn để tăng sức nặng, hoặc nhặt viên bi bỏ vào bát.

Góc bác sĩ. Người tiểu đường tập bài này rất tốt để giữ cảm giác bàn chân, nhưng phải kiểm tra lòng bàn chân mỗi ngày xem có vết xước, chai, phỏng rộp không. Chuột rút lòng bàn chân khi tập là bình thường lúc đầu, duỗi thẳng ngón chân là hết.

Bài 34. Lăn chân trên chai nước



Tác dụng. Xoa bóp cân gan chân, dải mô dày dưới lòng bàn chân hay bị viêm gây đau gót buổi sáng. Cũng kích thích hàng nghìn đầu dây thần kinh dưới chân, cải thiện cảm giác thăng bằng.

Cách làm. 1. Ngồi ghế, đặt một chai nước 500 ml đầy dưới lòng bàn chân trần. 2. Lăn chai từ gót đến ngón chân và ngược lại, ấn vừa đủ thấy dễ chịu. 3. Dừng 10 giây ở điểm đau, rồi lăn tiếp. Đổi chân.

Liều lượng. 2 phút mỗi chân, sáng khi vừa dậy và tối trước khi ngủ.

Dễ hơn. Ấn nhẹ, dùng chai rỗng. **Khó hơn.** Đứng lặn, hoặc dùng chai nước để ngăn đá cho người viêm cân gan chân.

Góc bác sĩ. Đau gót nhói bước đầu tiên khi rời giường là viêm cân gan chân điển hình, bài này cộng với Bài 41 và giày đế êm sẽ khỏi trong vài tuần. Người tiểu đường có tê chân không dùng chai lạnh, chỉ dùng chai thường.

Bài 35. Bơm cổ chân



Tác dụng. Kích hoạt "máy bơm" bắp chân đưa máu từ chân về tim, chống phù chân, chống huyết khối tĩnh mạch. Là bài đầu tiên bệnh nhân được dạy sau mọi ca mổ, cũng là bài cho chuyển xe, chuyển bay dài.

Cách làm. 1. Ngồi hoặc nằm, hai chân duỗi thẳng. 2. Kéo mũi chân về phía mình hết cỡ, giữ 2 giây, cảm thấy căng bắp chân. 3. Đạp mũi chân ra xa hết cỡ, giữ 2 giây. Rồi xoay cổ chân 5 vòng mỗi chiều.

Liều lượng. 20 lần kéo đạp, làm mỗi giờ khi ngồi lâu, hoặc 3 lượt mỗi ngày.

Để hơn. Tùng chân, biên độ nhỏ. **Khó hơn.** Vòng dây khăn qua mu bàn chân kéo giữ để tăng lực.

Góc bác sĩ. Phù chân về chiều, bắp chân một bên đau và sưng đột ngột là dấu hiệu huyết khối, đi khám ngay, không tự xoa bóp. Bài này là phòng ngừa, không phải điều trị khi đã có cục máu đông.

BÀI 36 ĐẾN 43

Phần 6. Thặng bằng, dẻo dai và linh hoạt

CHƯƠNG 7

Thăng bằng, dẻo dai và linh hoạt: không té ngã là không nằm một chỗ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, té ngã là nguyên nhân tử vong do tai nạn đứng thứ hai trên toàn cầu, và phần lớn ca nặng rơi vào người trên 65 tuổi. Thăng bằng là thứ ta **mất nhanh nhất** sau tuổi trung niên, nhưng cũng là thứ **lấy lại nhanh nhất** khi tập, chỉ vài tuần. Hệ thăng bằng gồm tai trong, mắt, và cảm giác từ bàn chân, khớp. Tám bài này huấn luyện cả ba, và kèm các bài kéo giãn để khớp còn đủ tầm cúi, xoay, với.

Bài 36. Đứng một chân



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/uutc-_VQCqA

Tác dụng. Bài kiểm tra và cũng là bài tập thăng bằng cơ bản nhất. Nghiên cứu theo dõi hàng nghìn người trung niên cho thấy ai không đứng một chân được 10 giây có nguy cơ tử vong trong 10 năm sau cao gần gấp đôi.

Cách làm. 1. Đứng cạnh tường hoặc sau lưng ghế, tay chạm nhẹ. 2. Nhấc chân phải lên, gõ gập, đứng trên

chân trái. Mắt nhìn một điểm cố định ngang tầm. 3. Giữ, đếm giây. Đổi chân.

Liều lượng. 30 giây mỗi chân, làm 3 lượt. Có thể làm khi đánh răng, chờ nước sôi.

Dễ hơn. Vịn ghế bằng hai tay, hoặc chỉ nhắc gót chân khỏi sàn. **Khó hơn.** Buông tay, khoanh tay trước ngực, rồi nhắm mắt, rồi đứng trên gôi mỏng.

Góc bác sĩ. Chao đảo là bình thường, đó là dấu hiệu hệ thăng bằng đang được huấn luyện lại. Tuyệt đối tập gần chỗ vịn trong tháng đầu. Người rối loạn tiền đình tập ở mức có vịn.

Bài 37. Đi nổi gót



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/bTE5UGktqPE

Tác dụng. Đi trên một đường thẳng, gót chân này chạm mũi chân kia, thu hẹp "đế" đứng của cơ thể để ép hệ thăng bằng làm việc. Là bài trong các chương trình phòng té ngã chuẩn của thế giới.

Cách làm. 1. Đứng dọc theo tường hoặc mép thảm, một tay chạm tường. 2. Bước chân phải lên trước, đặt

gót chân phải chạm ngay mũi chân trái, như đi trên một sợi dây. 3. Đi 10 bước, xoay người, đi về.

Liều lượng. 10 bước một lượt, làm 4 lượt.

Dễ hơn. Để khoảng cách nửa bàn chân giữa gót và mũi, vịn tường. **Khó hơn.** Buông tay, đi lùi nổi gót, hoặc vừa đi vừa xoay đầu sang hai bên.

Góc bác sĩ. Người mới, người dùng thuốc gây chóng mặt như thuốc huyết áp, thuốc ngủ, cần có người đứng cạnh những lần đầu. Đi bộ ngoài đường hay bị vấp là dấu hiệu cần tập bài này.

Bài 38. Đứng chuyển trọng tâm và xoay đầu



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/bTE5UGktqPE

Tác dụng. Té ngã thường xảy ra khi ta quay đầu nhìn, với tay lấy đồ, hoặc bước lệch. Bài này tập đứng tình huống đó: giữ thăng bằng trong khi mắt và đầu chuyển động.

Cách làm. 1. Đứng hai chân rộng bằng vai, gần tường.
2. Chuyển trọng tâm từ từ sang chân trái cho tới khi

chân phải gần nhấc, giữ 3 giây, rồi sang phải. Làm 10 lần. 3. Đứng yên, xoay đầu chậm sang trái rồi sang phải 10 lần, sau đó ngửa lên cúi xuống 10 lần, thân không lắc.

Liều lượng. Toàn bộ chuỗi làm 2 lượt mỗi ngày.

Dễ hơn. Vịn ghế, xoay đầu biên độ nhỏ. **Khó hơn.** Làm khi đứng một chân, hoặc nhắm mắt khi chuyển trọng tâm.

Góc bác sĩ. Nếu xoay đầu gây chóng mặt quay cuồng vài giây, có thể là chóng mặt tư thế lành tính, chữa được bằng nghiệm pháp tại phòng khám. Đừng cố tập, hãy đi khám.

Bài 39. Kéo giãn gân kheo đặt chân lên ghế



Tác dụng. Gân kheo sau đùi ngắn lại ở người ngồi nhiều, kéo khung chậu về sau, gây đau thắt lưng và dáng đi ngắn bước. Giãn được gân kheo là cúi nhặt đồ, đi tắt, cắt móng chân dễ hơn hẳn.

Cách làm. 1. Đứng trước một ghế thấp hoặc bậc thềm, đặt gót chân phải lên ghế, gối thẳng, mũi chân hướng lên. 2. Giữ lưng thẳng, gập người từ hông về phía trước cho tới khi thấy căng sau đùi, không gù lưng. 3. Giữ 30 giây, thở đều. Đổi chân.

Liều lượng. 30 giây mỗi chân, làm 2 lượt, tốt nhất sau khi tập hoặc buổi tối.

Dễ hơn. Ghế thấp hơn, hoặc ngồi trên giường duỗi thẳng một chân và với tay về mũi chân. **Khó hơn.** Ghế cao hơn, hoặc kéo mũi chân về phía mình.

Góc bác sĩ. Căng là được, đau nhói sau đùi hoặc tê lan xuống bắp chân là dấu hiệu chèn ép thần kinh tọa, giảm biên độ. Không nhún bật khi kéo giãn.

Bài 40. Kéo giãn cơ gấp hông tư thế quỳ



Tác dụng. Cơ gấp hông ở phía trước háng co ngắn lại sau hàng chục năm ngồi, kéo lưng dưới võng xuống và làm ta không đứng thẳng hẳn được. Giãn cơ này là lấy lại dáng đứng thẳng và bước dài.

Cách làm. 1. Quỳ gối phải xuống thảm hoặc gối mềm, chân trái đặt ra trước, gối vuông góc, tay vịn ghé bên cạnh. 2. Siết mông phải, đẩy hông nhẹ ra trước cho tới khi thấy căng ở mặt trước háng phải. Thân thẳng, không ưỡn lưng. 3. Giữ 30 giây. Đổi bên.

Liều lượng. 30 giây mỗi bên, làm 2 lượt.

Dễ hơn. Đứng cạnh tường, đưa một chân ra sau, siết hông đẩy hông ra trước. **Khó hơn.** Giơ tay cùng bên gối quỳ lên trần và nghiêng nhẹ sang bên đối diện.

Góc bác sĩ. Người đau gối quỳ lên gối dày hoặc chọn phiên bản đứng. Người thay khớp háng hỏi bác sĩ về biên độ được phép.

Bài 41. Xoay cổ chân và kéo giãn bắp chân



Tác dụng. Cổ chân cứng là nguyên nhân ít được đề ý của té ngã: chân không "ăn" được mặt đường không bằng phẳng. Bắp chân căng còn gây đau gót, chuột rút đêm.

Cách làm. 1. Ngồi, gác cổ chân phải lên đùi trái, tay nắm bàn chân xoay 10 vòng mỗi chiều. Đổi chân. 2. Đứng đối diện tường cách một sải tay, hai tay chống tường, chân phải lùi ra sau, gót ép sàn, gối thẳng, đẩy hông về tường tới khi căng bắp chân. Giữ 30 giây. 3.

Vẫn tư thế đó, chùng gối chân sau xuống một chút để căng phần bắp chân sâu. Giữ 30 giây. Đổi chân.

Liều lượng. Chuỗi trên làm 1 lượt buổi sáng, 1 lượt buổi tối.

Để hơn. Chỉ làm bước 1 và 2. **Khó hơn.** Đứng trên mép bậc thêm, để gót thông xuống thấp hơn mũi chân.

Góc bác sĩ. Chuột rút bắp chân về đêm ở người lớn tuổi đa số do bắp chân căng và thiếu nước, không phải thiếu canxi. Kéo giãn trước khi ngủ và uống đủ nước sẽ giảm rõ. Nếu vẫn chuột rút thường xuyên kèm chân lạnh, tím, đi khám mạch máu.

Bài 42. Với tay lên trời và nghiêng người



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/6I4KvxWpCpM

Tác dụng. Kéo dài toàn bộ thân bên, mở lồng ngực, giãn cơ liên sườn, giúp thở sâu hơn. Rất tốt khi vừa ngủ dậy hoặc sau khi ngồi lâu.

Cách làm. 1. Đứng hai chân rộng bằng vai, đan hai bàn tay, lật lòng bàn tay lên trần, duỗi thẳng tay vươn lên cao nhất, kiễng gót nếu vững. Hít sâu, giữ 5 giây. 2. Hạ

gót, giữ tay trên cao, nghiêng thân sang trái tới khi căng bên sườn phải. Giữ 15 giây, thở đều. 3. Về giữa, nghiêng sang phải. Giữ 15 giây.

Liều lượng. 3 vòng, làm sáng và chiều.

Đễ hơn. Ngồi trên ghế làm cùng động tác, không kiễng gót. **Khó hơn.** Nghiêng sâu hơn, kết hợp xoay nhẹ thân.

Góc bác sĩ. Người loãng xương không nghiêng gập quá sâu ra trước, chỉ nghiêng sang bên. Người huyết áp cao đừng giữ tay trên cao quá lâu nếu thấy chóng mặt.

Bài 43. Ngồi xổm sâu có vịn



Tác dụng. Người Việt xưa ngồi xổm cả đời nên gối, háng, cổ chân rất dẻo. Ngồi ghế nhiều làm ta mất tư thế này. Ngồi xổm sâu giữ được là dấu hiệu khớp còn khỏe, và là nền cho việc tự ngồi bệt rồi đứng lên ở Bài 48.

Cách làm. 1. Đứng đối diện lưng ghế hoặc khung cửa, hai tay nắm chắc, chân rộng bằng vai, mũi chân xoay ra ngoài một chút. 2. Từ từ hạ hông xuống thấp nhất có thể, gót cổ giữ trên sàn, lưng thẳng, dùng tay đỡ bớt

sức nặng. 3. Giữ ở dưới, thở đều, nhún nhẹ. Rồi dùng tay và chân đứng lên.

Liều lượng. Giữ 20 đến 30 giây, làm 3 lượt.

Dễ hơn. Không xuống hết, kê gót chân lên cuốn sách mỏng nếu gót nhấc khỏi sàn. **Khó hơn.** Buông tay, giữ 1 đến 2 phút, đọc sách trong tư thế ngồi xổm.

Góc bác sĩ. Người thoái hóa gối nặng, người thay khớp gối, thay khớp háng không ngồi xổm sâu, dừng ở góc bác sĩ cho phép. Với người khác, gối "lao xao" mà không đau là bình thường, cứ tập.

BÀI 44 ĐẾN 50

Phần 7. Sức mạnh và chức năng

CHƯƠNG 8

Sức mạnh và chức năng: giữ cơ để giữ tự do

Sau tuổi 50, cơ bắp không tự giữ được nếu không có lực kháng. Đi bộ và dưỡng sinh rất tốt cho tim, nhưng **không đủ để giữ cơ**. Tôi gặp rất nhiều người đi bộ mỗi ngày mà chân vẫn yếu dần, vì thiếu đúng một thứ: tập kháng lực. Bảy bài này dùng chính trọng lượng cơ thể và vật dụng trong nhà làm tạ. Tập 2 đến 3 buổi mỗi tuần, cách ngày, cơ sẽ lên trong 8 tuần ở bất kỳ tuổi nào.

Bài 44. Hít đất chống bàn



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/dCWQrw9_Prk

Tác dụng. Rèn ngực, vai, tay sau, đồng thời siết cơ lõi. Số cái hít đất là thước đo trung thực của sức khỏe tổng thể: nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí JAMA Network Open theo dõi hơn nghìn người trong 10 năm thấy nhóm hít đất được trên 40 cái có tỷ lệ biến cố tim mạch thấp hơn hẳn nhóm dưới 10 cái. Hít đất chống bàn là phiên bản an toàn cho mọi lứa tuổi.

Cách làm. 1. Đứng đối diện mép bàn hoặc mặt bếp chắc chắn, hai tay chống rộng hơn vai một chút, lùi chân ra sau cho thân thẳng nghiêng. 2. Gập khuỷu tay chéch 45 độ so với thân, hạ ngực về phía bàn, hít vào. 3. Đẩy thẳng tay, thở ra. Toàn thân luôn là một đường thẳng.

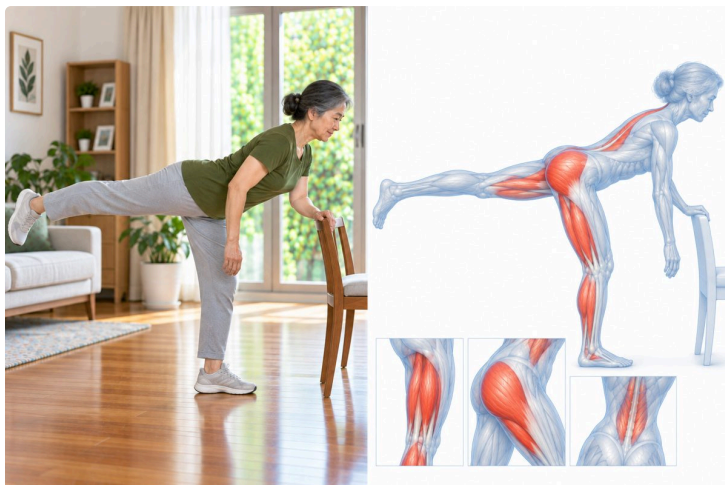
Liều lượng. 10 đến 12 lần, làm 3 hiệp, cách ngày.

Dễ hơn. Chống tường thay vì bàn, càng đứng càng nhẹ.

Khó hơn. Chống lên ghế thấp, rồi xuống sàn với gối chạm, rồi hít đất đầy đủ.

Góc bác sĩ. Khuỷu tay xòe ngang vuông góc là lỗi gây đau vai hàng đầu, luôn giữ 45 độ. Đau cổ tay thì chống trên nắm đấm. Người bệnh tim chưa ổn định bắt đầu từ mức tường và không nín thở.

Bài 45. Gập người một chân vịn ghế



► Xem video bác sĩ hướng dẫn bài này: youtu.be/jf6lIWUB2Nc

Tác dụng. Bài kiểm tra thăng bằng trung thực nhất của cơ thể, đồng thời rèn gân kheo, mông, lưng dưới. Tập bài này giống như biến cơ thể thành một chiếc cần câu vững chãi. Là "liều thuốc phòng té ngã" không mất tiền.

Cách làm. 1. Đứng cạnh lưng ghế, tay trái vịn nhẹ, trụ trên chân trái, gối hơi chùng. 2. Gập người từ hông về

trước, lưng thẳng, đồng thời duỗi chân phải ra sau cho tới khi thân gần song song sàn. 3. Siết mông, đứng dậy chậm. Đổi bên.

Liều lượng. 8 đến 10 lần mỗi chân, làm 2 đến 3 hiệp.

Dễ hơn. Gập ít hơn, vịn hai tay, chân sau chỉ chạm nhẹ mũi xuống sàn. **Khó hơn.** Buông tay, hoặc cầm chai nước ở tay đối diện chân trụ.

Góc bác sĩ. Gập từ hông chứ không gù lưng. Chao đảo trong tuần đầu là bình thường. Người thoát vị đĩa đệm đang đau cấp hoãn bài này.

Bài 46. Xách nặng đi bộ



Tác dụng. Bài "người nông dân xách nước". Rèn lực bóp tay, vai, cơ lõi, chân, tất cả cùng lúc, đúng như cách ta xách túi đi chợ hay bê chậu cây. Đây là bài tập chức năng thuần túy nhất.

Cách làm. 1. Chuẩn bị hai túi hoặc hai chai nước nặng bằng nhau, ban đầu mỗi bên 2 đến 3 kg, ví dụ chai 2 lít. 2. Đứng thẳng, xách hai bên, vai kéo nhẹ ra sau và xuống, bụng siết, mắt nhìn thẳng. 3. Đi chậm 20 bước, quay lại, đi 20 bước. Đặt xuống bằng cách ngồi xuống, lưng thẳng.

Liều lượng. 40 bước một lượt, nghỉ 1 phút, làm 3 lượt, cách ngày.

Dễ hơn. Xách một bên, tay kia vịn, hoặc chỉ đứng giữ 30 giây. **Khó hơn.** Tăng lên 5 kg mỗi bên bằng bao gạo, hoặc đi lên cầu thang.

Góc bác sĩ. Không nghiêng người sang một bên khi xách, đó là lúc lưng dễ bị. Người thoát vị đĩa đệm, người sa tạng chậu bắt đầu từ mức rất nhẹ và thở đều.

Bài 47. Kéo khăn chèo thuyền



Tác dụng. Rèn cơ lưng giữa và tay trước, nhóm cơ kéo mà hầu hết bài tập tại nhà bỏ sót. Lưng khỏe cân bằng với ngực, vai không gù về trước. Chỉ cần một chiếc khăn tắm.

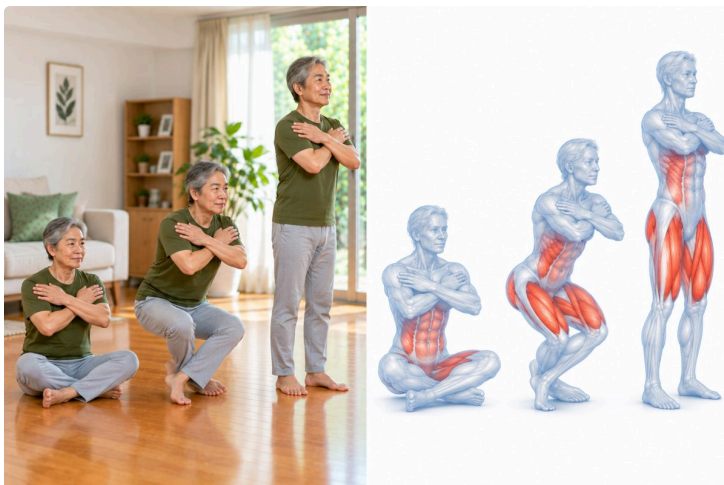
Cách làm. 1. Ngồi trên sàn, chân duỗi thẳng, vòng khăn tắm qua hai lòng bàn chân, hai tay nắm hai đầu khăn. 2. Lưng thẳng, kéo hai đầu khăn về phía bụng, khuỷu tay đi sát sườn, siết hai bả vai vào nhau. Chân đẩy ngược lại để tạo lực cản. 3. Giữ 3 giây, thả chậm.

Liều lượng. 12 lần, làm 3 hiệp.

Dễ hơn. Ngồi trên ghế, vòng khăn qua một chân, kéo từng tay. **Khó hơn.** Giữ 10 giây mỗi lần, hoặc chuyển sang Bài 49.

Góc bác sĩ. Người không ngồi được trên sàn làm phiên bản ghế. Bài này rất phù hợp người bị đau vai do gù, tập cùng Bài 26.

Bài 48. Ngồi xuống sàn rồi đứng lên



Tác dụng. Nghiên cứu ở Brazil trên hơn 2.000 người từ 51 đến 80 tuổi thấy khả năng ngồi bệt xuống sàn rồi đứng dậy mà không cần chống tay hay gối là **một trong những dự báo tuổi thọ mạnh nhất**. Bài này gom sức mạnh, dẻo dai, thăng bằng vào một động tác. Người còn tự đứng dậy từ sàn là người khi ngã vẫn tự dậy được.

Cách làm. 1. Đứng giữa phòng, cạnh ghế để vịn khi cần. 2. Bắt chéo một chân ra trước, từ từ hạ người ngồi bệt xuống sàn, dùng tay hoặc gối chống nếu cần. 3. Từ

tư thế ngồi, đứng dậy, cố gắng dùng càng ít điểm tựa càng tốt. Ghi nhớ mình cần mấy điểm tựa: mỗi tay, mỗi gối, mỗi lần chống là một điểm.

Liều lượng. 5 lần xuống và lên, làm 2 lượt, cách ngày.

Dễ hơn. Xuống trên đệm hoặc giường thấp trước, chống tay thoải mái. **Khó hơn.** Không chống tay, không chống gối, khoanh tay trước ngực.

Góc bác sĩ. Người thay khớp háng, gối nặng, hoặc đang chóng mặt không tập một mình. Tuần đầu chỉ tập phần đứng dậy từ ghế thấp dần. Giảm được một điểm tựa sau 4 tuần là thành công lớn.

Bài 49. Bám khung cửa kéo người



Tác dụng. Treo và kéo là bài rèn lực bóp tay, vai, lưng, và kéo giãn cột sống. Lực bóp và sức kéo giảm nhanh ở người lớn tuổi, nhưng cũng lên lại nhanh. Không cần xà, chỉ cần một khung cửa chắc.

Cách làm. 1. Đứng trong khung cửa, hai tay nắm hai bên khung ở ngang ngực, chân đặt sát mép khung. 2. Ngả người ra sau cho tay duỗi thẳng, thân thẳng, trọng lượng dồn lên tay. 3. Kéo người về phía khung, siết bả vai, khuỷu tay đi sát sườn. Thả chậm ra.

Liều lượng. 10 lần, làm 3 hiệp, cách ngày.

Dễ hơn. Chân đặt xa khung hơn để thân nghiêng ít, hoặc chỉ ngả ra và giữ 20 giây. **Khó hơn.** Chân đặt gần hơn, thân nghiêng nhiều; nếu có xà đơn thì treo người 20 đến 30 giây.

Góc bác sĩ. Kiểm tra khung cửa và bản lề chắc chắn trước. Người đau vai do rách gân không ngả sâu. Bài treo người thật sự trên xà rất tốt cho vai và cột sống, người trên 60 vẫn tập được nếu tăng dần từ 5 giây.

Bài 50. Giậm gót giữ xương



Tác dụng. Xương cần lực nén để giữ mật độ. Nhún gót rồi thả rơi gót xuống sàn tạo xung lực nhẹ chạy dọc xương chân, cột sống, kích thích tế bào tạo xương. Nghiên cứu trên phụ nữ sau mãn kinh cho thấy 50 lần giậm gót mỗi ngày giúp giữ mật độ xương hông. Đây là bài kết thúc cuốn sách, vì cơ khỏe mà xương giòn thì vẫn gãy.

Cách làm. 1. Đứng thẳng, hai tay vịn nhẹ lưng ghế, chân rộng bằng hông. 2. Nhón gót lên cao, giữ 1 giây.

3. Thả cho gót rơi xuống sàn khá nhanh, chân thẳng, để cảm thấy xung lực nhẹ lan lên thân. Không đau.

Liều lượng. 20 lần, làm 2 đến 3 lượt, mỗi ngày.

Dễ hơn. Hạ gót có kiểm soát, không thả rơi. **Khó hơn.** Bật nhảy nhẹ hai chân tại chỗ 10 lần, hoặc nhảy dây chậm.

Góc bác sĩ. Người đã được chẩn đoán loãng xương nặng hoặc từng gãy xương do loãng xương chỉ làm mức dễ hơn và hỏi bác sĩ. Người thay khớp không thả rơi gót. Kết hợp bài này với đủ đạm, canxi, vitamin D ở phần tiếp theo mới đủ bộ.

Việc cần làm ngay

Chọn 2 bài ở phần này để tập cách ngày cùng 5 bài anh chị đã chọn. Ghi ngày bắt đầu vào bảng theo dõi ở cuối sách.

ĐỀ BÀI TẬP PHÁT HUY HẾT TÁC DỤNG

Phần thưởng. Dinh dưỡng và lối sống trường thọ

CHƯƠNG 9

Dinh dưỡng và lối sống: bài tập chỉ là một nửa câu chuyện

Tập mà thiếu đạm thì cơ không lên. Tập mà thiếu ngủ thì cơ không sửa. Tập mà căng thẳng triền miên thì hormone stress bào mòn cơ nhanh hơn ta xây. Phần này gói gọn những điều tôi dặn bệnh nhân nhiều nhất, không cầu kỳ, làm được ngay trong bếp nhà mình.

1. Đạm: nguyên liệu xây cơ, người lớn tuổi cần nhiều hơn người trẻ

Nghịch lý là càng lớn tuổi, cơ thể càng "khó nghe" tín hiệu từ đạm, nên **cần ăn nhiều đạm hơn chứ không ít đi**. Khuyến nghị cho người trên 50 là khoảng 1,2 đến 1,5 gam đạm cho mỗi kg cân nặng mỗi ngày. Người 55 kg cần khoảng 65 đến 80 gam đạm. Để dễ hình dung, một lòng bàn tay thịt cá cỡ vừa cho khoảng 20 đến 25 gam.

- Chia đều đạm cho cả ba bữa, mỗi bữa 20 đến 30 gam. Bữa sáng là bữa hay thiếu đạm nhất: bún phở nhiều tinh bột, ít thịt.
- Nguồn đạm tốt, rẻ, quen thuộc: trứng, cá, đậu phụ, tôm, thịt nạc, sữa và sữa chua không đường, các loại đậu.
- Người ăn chay cần kết hợp đậu với ngũ cốc trong cùng bữa, và cân nhắc bổ sung vitamin B12.
- Sau buổi tập, ăn bữa có đạm trong vòng 1 đến 2 giờ, ví dụ một cốc sữa hoặc hai quả trứng.

2. Canxi và vitamin D: cho xương đi cùng cơ

Cơ khỏe mà xương giòn thì vẫn gãy khi ngã. Người trên 50 cần khoảng 1.000 đến 1.200 mg canxi mỗi ngày, tương đương 3 khẩu phần sữa hoặc sữa chua, cộng thêm cá nhỏ ăn cả xương, tôm tép, rau lá xanh đậm, đậu phụ.

Vitamin D giúp hấp thu canxi. Người Việt thiếu vitamin D rất phổ biến dù nắng nhiều, vì ta tránh nắng kỹ. Phơi nắng tay chân 15 phút trước 9 giờ sáng vài lần mỗi tuần, hoặc hỏi bác sĩ về liều bổ sung sau khi xét nghiệm.

3. Nước: cơ bắp là 75 phần trăm nước

Người lớn tuổi mất dần cảm giác khát nên hay thiếu nước mà không biết. Thiếu nước làm chuột rút, chóng mặt khi đứng dậy, mệt mỏi, táo bón. Uống khoảng 1,5 đến 2 lít mỗi ngày tùy cân nặng và thời tiết, chia nhỏ suốt ngày, không uống dồn.

Mẹo đơn giản: một cốc nước ấm ngay khi ngủ dậy, một cốc trước mỗi bữa ăn, một cốc sau mỗi buổi tập. Nước tiểu màu vàng nhạt là đủ nước.

4. Giấc ngủ: xương sửa chữa cơ bắp

Hormone tăng trưởng, chất "sửa cơ" chính, tiết ra nhiều nhất trong giấc ngủ sâu ở nửa đầu đêm. Ngủ dưới 6 giờ làm cơ mất nhanh hơn và làm bụng tích mỡ nhiều hơn.

- Cố định giờ dậy, kể cả cuối tuần. Giờ dậy đều quan trọng hơn giờ ngủ đều.
- Tắt điện thoại, tivi ít nhất 30 phút trước ngủ. Ánh sáng xanh chặn melatonin.
- Phòng ngủ tối, mát, yên. Nếu tỉnh giấc giữa đêm, làm Bài 7 thở bụng thay vì nhìn đồng hồ.
- Tập thể dục buổi sáng hoặc chiều, tránh tập nặng trong 2 giờ trước ngủ.

5. Căng thẳng: kẻ ăn mòn cơ âm thầm

Căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol, hormone phân giải cơ và tích mỡ bụng. Không ai sống mà không có áp lực, nhưng có thể hạ nó mỗi ngày bằng vài việc nhỏ:

- 5 phút thở bụng 4-6 (Bài 7) vào buổi sáng và trước ngủ.
- Vẩy tay Dịch Cân Kinh (Bài 6) 10 phút lúc hoàng hôn.
- Đi bộ ngoài trời, có cây xanh, mỗi ngày 20 phút.
- Một việc "cho mình" mỗi ngày: chăm cây, nghe nhạc, gọi điện cho người bạn cũ.

6. Mục đích sống và kết nối: điều những người sống trăm tuổi có chung

Ở những vùng có nhiều người sống trên 100 tuổi, người ta thấy hai điểm chung ngoài ăn uống và vận động: **có lý do để thức dậy mỗi sáng, và có người để ăn cùng.** Người có mục đích sống rõ ràng có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn rõ rệt. Người cô đơn có nguy cơ tương đương hút 15 điếu thuốc mỗi ngày.

Vì thế, hãy tập cùng ai đó: vợ chồng, hàng xóm, nhóm bạn. Rủ được một người tập cùng là anh chị tăng gấp đôi khả năng duy trì sau 3 tháng. Đó cũng là lý do tôi tổ chức các lớp tập buổi sáng theo nhóm, xem thông tin ở cuối sách.

7. Phòng bệnh chủ động: khám trước khi cơ thể lên tiếng

Sau 50 tuổi, mỗi năm một lần: huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng thận. Sau 50 với nữ và 60 với nam: đo mật độ xương. Đừng đợi gãy xương mới biết mình loãng xương.

8. Môi trường sống: dọn nhà để không té ngã

Hơn một nửa ca té ngã xảy ra ngay trong nhà. Hôm nay, đi một vòng nhà và làm 5 việc: bỏ thảm trơn nhỏ, lắp đèn ngủ ở hành lang ra nhà vệ sinh, gắn tay vịn trong nhà tắm, dán miếng chống trượt sàn tắm, kê đồ hay dùng ở tầm tay không phải trèo ghế.

Bảng theo dõi 4 tuần

Ghi lại để thấy mình tiến bộ. Chỉ số không nói dối.

	Tuần 1 (ngày bắt đầu: ____)	Tuần 4 (ngày: ____)
Đứng lên ngồi xuống trong 30 giây	____ lần	____ lần
Đứng một chân (chân yếu hơn)	____ giây	____ giây
Ngồi xuống sàn rồi đứng lên, số điểm tựa	____ điểm	____ điểm
Số ngày tập trong tuần	____ / 7	____ / 7
Điều tôi làm được mà trước đây khó		

Bài tôi chọn	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4
Bài ____				
Bài ____				

Bài tôi chọn	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4
Bài ____	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bài ____	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bài ____	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bài ____	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Bài ____	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Lời cuối của bác sĩ

Sống thọ không phải là mục tiêu cuối cùng. Điều đáng giá hơn là sống đủ lâu mà vẫn còn khỏe, còn tự đi chợ, còn bế được cháu, còn đủ bình an để tận hưởng những người mình yêu thương. Năm mươi bài trong sách này không cần làm hết. Chỉ cần mỗi ngày làm vài bài, đều đặn, và không bỏ cuộc sau tuần thứ hai, là cô chú anh chị đã đi trước phần lớn người cùng tuổi rồi.

Nếu tự tập một mình khó duy trì, hãy tìm người tập cùng. Tôi và các học viên tập cùng nhau mỗi sáng 6 giờ trong lớp [Khí Công Trường Thọ](#), 28 buổi trực tiếp, có bác sĩ hướng dẫn và sửa từng động tác. Thông tin ở trang cuối.

Chúc cô chú anh chị khỏe mạnh, và hẹn gặp trong buổi tập sáng mai.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Chúc

Lưu ý: nội dung sách mang tính hướng dẫn chung, không thay thế việc khám và tư vấn trực tiếp của bác sĩ

điều trị. Người có bệnh nền hãy hỏi bác sĩ trước khi bắt đầu chương trình tập.

Bước tiếp theo

Tập cùng bác sĩ mỗi sáng: lớp Khí Công Trường Thọ

28 buổi tập trực tiếp qua nhóm kín, 6 giờ đến 7 giờ sáng, khai giảng thứ Hai hàng tuần. Bác sĩ Chúc hướng dẫn và sửa từng động tác. Học phí 499.000 đồng cho trọn khóa.

Đăng ký tại: drchuc.com/khi-cong-truong-tho

Kiểm tra nguy cơ loãng xương và mất cơ miễn phí

Bài kiểm tra 2 phút, nhận kết quả và hướng dẫn qua email.

Tại: drchuc.com

Theo dõi video bài tập mỗi ngày

Facebook và YouTube: tìm "Bác sĩ Chúc". Mọi kênh chính thức đều được dẫn từ drchuc.com.

© 2026 Bác sĩ Nguyễn Xuân Chúc. Sách dành cho người mua, vui lòng không sao chép và phát tán. Mọi hình thức chia sẻ xin dẫn về drchuc.com.